

Fragmentasi Data Kematian Ibu dan Bayi di Indonesia: Tantangan Integrasi Lintas Instansi dalam Era Big Data

Oleh: Nouval Arya Junior (23083010093)

Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) merupakan dua indikator utama yang mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus kondisi demografis suatu bangsa. Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam menekan kedua angka tersebut. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017, AKI tercatat sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup, jauh di atas target Sustainable Development Goals (SDGs) yang menetapkan angka di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Di balik persoalan angka tersebut, terdapat permasalahan mendasar yang kerap luput dari perhatian, yaitu lemahnya integrasi data antara instansi-instansi yang bertanggung jawab dalam pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan data kesehatan ibu dan anak.

Data kematian ibu dan bayi di Indonesia dihasilkan oleh berbagai institusi secara bersamaan namun tidak terkoordinasi dengan baik. Puskesmas dan rumah sakit sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan mencatat kejadian kematian melalui sistem informasi masing-masing yang seringkali tidak kompatibel satu sama lain. Data tersebut kemudian dilaporkan secara berjenjang ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, lalu ke Dinas Kesehatan Provinsi, dan akhirnya bermuara di Kementerian Kesehatan. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan pencatatan melalui mekanisme registrasi vital dan sensus penduduk secara terpisah. Kedua jalur pengumpulan data ini hampir tidak pernah dipertemukan secara sistematis, sehingga angka yang dihasilkan keduanya kerap berbeda secara signifikan.



Gambar 1. Alur Pelaporan Data Kematian Ibu dan Bayi di Indonesia

Seperti yang terlihat pada Gambar 1, pelaporan data mengalir secara linier dari fasilitas kesehatan di tingkat bawah menuju instansi pusat. Namun, alur tersebut menyimpan sejumlah titik rawan. Pertama, belum seluruh puskesmas dan rumah sakit, khususnya di wilayah terpencil dan perbatasan, terhubung dengan sistem pelaporan digital. Sebagian besar masih mengandalkan pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan dan keterlambatan. Kedua, format dan definisi operasional yang digunakan antara Kementerian Kesehatan dan BPS tidak sepenuhnya seragam, sehingga data yang sama dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda. Ketiga, tidak ada

mekanisme rekonsiliasi data yang baku dan berkala antara kedua lembaga tersebut. Kondisi ini menciptakan situasi di mana setiap instansi memiliki versinya sendiri atas realitas yang sama.

Permasalahan ini semakin kompleks dengan hadirnya fragmentasi kelembagaan. Selain Kementerian Kesehatan dan BPS, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) turut mengelola data terkait kesehatan ibu melalui program keluarga berencana. Ketiga lembaga ini bekerja dengan basis data yang berbeda, platform yang tidak saling terhubung, dan sistem pembaruan data yang tidak sinkron. Akibatnya, pengambil kebijakan tidak jarang dihadapkan pada data yang saling bertentangan, yang pada akhirnya menghambat perumusan intervensi yang tepat sasaran. Dalam konteks big data, kondisi ini mencerminkan kegagalan dalam membangun infrastruktur data yang terintegrasi, meskipun volume data yang tersedia sebenarnya sangat besar.

Integrasi data kematian ibu dan bayi lintas instansi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut tata kelola data nasional yang lebih luas. Diperlukan komitmen bersama antara Kementerian Kesehatan, BPS, BKKBN, serta pemerintah daerah untuk menyepakati standar data yang seragam dan membangun platform pertukaran data yang aman dan berkelanjutan. Upaya ini dapat dimulai dengan mengintegrasikan sistem informasi yang sudah ada, seperti SIRS (Sistem Informasi Rumah Sakit) dan SIMPUS (Sistem Informasi Puskesmas), ke dalam satu ekosistem data nasional. Hanya melalui integrasi data yang sungguh-sungguh, Indonesia dapat menghasilkan gambaran yang akurat tentang kondisi kesehatan ibu dan anak, sekaligus merancang kebijakan yang lebih efektif untuk menurunkan angka kematian yang masih memprihatinkan.

Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2017). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017*. Jakarta: BPS.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Profil Kesehatan Indonesia 2019*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Mahendradhata, Y., et al. (2017). *The Republic of Indonesia Health System Review*. WHO Regional Office for South-East Asia.
- Poedjastoeti, W., & Murti, B. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Pelaporan Data Kematian Ibu. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 14(2), 123–131.